EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 83899
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2024-05-06 11:11:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARTA JOSEFINA SEPULVEDA ACUNA			RUN	: 8.220.462-8
F.Nac	: 18-08-1959	Edad	: 64 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: QUINPEUMO ARIZONA			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 88813523		
Fecha Ingreso	: 2024-04-09	Fecha Egreso	: 2024-05-06 11:11:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. C53.0-TUMOR MALIGNO DE ENDOCERVIX

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Cancer Cervico uterino

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R34-ANURIA Y OLIGURIA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente conocida ingresada el 09/03 desde UGO en contexto de anemia severa asociado a sepsis pelvica (cultivo de flujo vaginal: Estreptococo anginosus en contexto de cuadro actual, completando 5 dias con metro/ ceftriaxoina asociado a tranfusion de 4 UGR con parcial mejoria, posteriro traslape a clindamicina + meropenem. Asociado a cuadro descrito presenta descompensacion de su ERC e ICC manteniendo anasarca a pesar de maneko con antihipertensivos y diureticos.
el 01/04 fue traslada a Hospital de Concepción para Inicio de Radioterapia, logrando recibir solo 4/21 sesiones, por mala tolerancia clinica asociado a sepsis mencionada. el 04/04 fue evaluada por urología indicando instalacion de cateter doble J , lo cual se instala en HMM el 09/04 sin complicaciones. el dia 10/04 comiensa con HD y presenta diuresis efectiva, mejorando tambíen su creatininemia. Pese a esto se toma tc de abdomen de control que evidencia un absceso en hipogastrio que se drenó por laparotomía el 12/04/24. Posterior a esto comienza nuevamente con anuria, con compromiso del estado general, con alteración nuevamente de la función renal y anasarca. Además con parámetros infecciosos al alza, por lo que se pancultiva, evidenciando HC 1-1con levaduras (cándida) y HC 3 con cocáceas Gram (+) en racimos. Se escala en tto Atb con Vancomicina y Meropenem, asociándose como antifúngico anidulafungina.
Paciente evaluada por Ginecooncólogo (Dr Peruggi), quien indica limitación del esfuerzo terapéutico.
Portadora de múltiples condiciones a sociadas a la evolución de su patología basal, entre ellos, Insuficiencia renal, anasarca. Manejada en múltiples Servicios, dada de alta por Ginecología (Paciente Oncológica), Medicina Interna.
Actualmente se hicieron las gestiones para enviar a Hospitalización domiciliara, para continuar manejo por cuidados páliativos.

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

FECHA	CIRUJANO	INTERVENCION	CODIGO
2024-01-16	Simone Lambert Diaz	Raspado uterino diagnóstico o terpéutico por metrorragia o restos de aborto	20.04.002

FECHA	CIRUJANO	INTERVENCION	CODIGO
2024-04-09	Gonzalo Irusta Pineda	Nefrostomía , nefropexia y/o nefrotomía por litiasis	19.02.012

FECHA	CIRUJANO	INTERVENCION	CODIGO
2024-04-12	Mauricio Vespa Bardier	Laparotomía exploradora c/s liberación de adherencias c/s drenaje c/s biopsia	18.02.004

INDICACIONES AL ALTA

1. Hospitalizacion domiciliaria (HODOM)
2. MANTENER SNG
3. Reposo en cama con uso de colchón antiescara con movilización cada 3 horas
4. Régimen liviano a tolerancia X SNG
5. Linezolid 600 mg ev cada 12 hrs x 5 días
6. Voriconazol 200 mg ev cada 12 hrs x 2 dias
7. Paracetamol 1 gr cada 12 horas /x SNG
8. Slo-K 600 mg cada 8 hrs X SNG
9. Levetiracetan 500 mg cada 12 hrs X SNG
10. Fenitoina 100 mgs cada 8 hrs x SNG
11. Paciente en LET (NO RCP, NO IOT)
12. Control de examenes de laboratorio (Recuento Globular, PCR)
13. CONTINUAR MANEJO POR CUIDADOS PALIATIVOS AL ALTA DE HODOM

CARO HERRERA VICTOR ISIDRO
MEDICO TRATANTE
9196516-K

JEFE SERVICIO